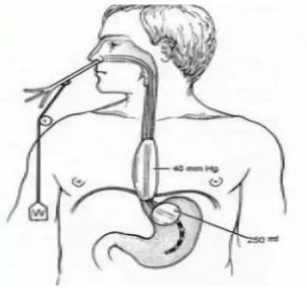
头转向一侧,防止吸入性肺炎发生　　时间久易缺血坏死,每12h气囊放空10-20min,总时间不超过3-5d

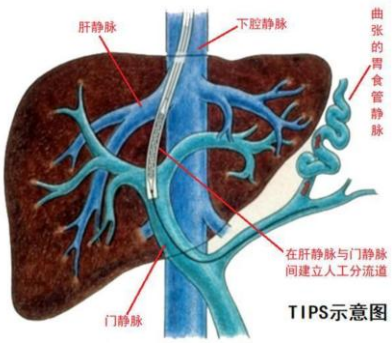


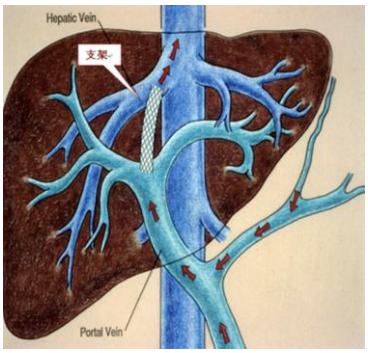
图 43-3　三腔二囊管压迫止血法





TIPS是微创操作,通过放支架解决了门脉高压以及由门脉高压导致的并发症。
解决侧支循环、腹水、食管静脉破裂出血、腹水导致的低钾低氯碱中毒、肝性脑病





外科治疗门脉高压的目的不是去降门脉高压,而是去预防和控制食管胃底曲张破裂出血。
因为降门脉高压会让回到肝脏的血液减少,是坏事

门V→胃底~~食管~~静脉→奇V→上腔V　五、断流术止血效果好、创伤小、操作简单

ttsx	断流术（常用）	分流术 外科手术,非TIPS(介入)
门脉压力	↑把侧支循环离断了	↓
再出血率	↑门脉压力高→新侧支循环出血	↓
机制	阻断门-奇静脉反常血流	门-腔静脉建立分流通道
方法	脾切除+贲周血管离断术 （冠状/胃短/胃后/左膈下静脉） 管哥断后	①非选择性：门静脉-下腔静脉、肠系膜上静脉-下腔静脉、近端脾-肾静脉分流术 ②选择性：远端脾-肾静脉分流术（yyps）
肝性脑病发生率	较低	选择性较低、非选择性较高 更多血未经过肝脏解毒
打击肝功能	较小	较大

任何手术都会　做起来简单且快,保证入肝血流

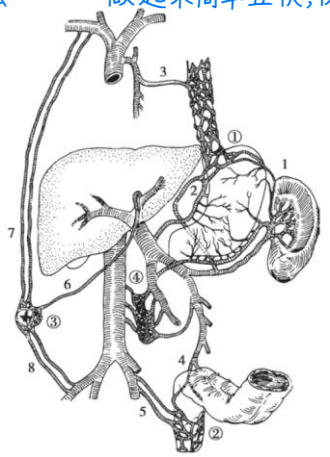


图 43-1　门静脉与腔静脉之间的交通支
1. 胃短静脉　2. 胃冠状静脉　3. 奇静脉　4. 直肠上静脉　5. 直肠下静脉、肛管静脉　6. 脐旁静脉　7. 腹上深静脉　8. 腹下深静脉　①胃底、食管下段交通支　②直肠下端、肛管交通支　③前腹壁交通支　④腹膜后交通支

断流术:门V→胃底食管下段V→奇V→上腔V

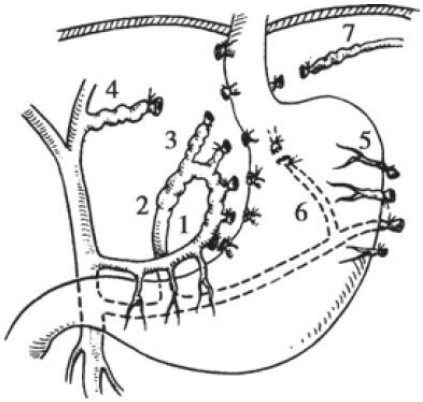


图 43-5　贲门周围血管离断术示意图
1. 胃支　2. 食管支　3. 高位食管支　4. 异位高位食管支　5. 胃短静脉　6. 胃后静脉　7. 左膈下静脉